

MARIANA VENANCIA SANCHES	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	JAH = 30,7 e/lv
OXIMETRIA:	

14/ M. Delh 27'
 10 Fuga = 17.4 l/min
 21 JAH = 0.6 Relata que está sonolenta — Jua

22/10 P = 7cmH₂O
 21 JAH = 0.7/h
 Fuga = 14.8 Jua

22/11 P = 7cmH₂O
 21 JAH = 0.5
 M. de uso: 7h 31 Jua

27/11 P = 7cmH₂O
 21 JAH = 0.6
 M. de uso: 8hs Jua

2/2/22 P = 7cmH₂O
 JAH = 0.8/h
 M. de uso: 7h 30' ajuste másc.
 TROCO O filtro al queixas Jua

04/06/22 P = 7cmH₂O
 JAH = 0.5
 M. de uso: 8h 6' Jua

12/08 P = 7.0 cmH₂O
 22 JAH = 0.6
 M. de uso: 8h 8'

11/10 P = 7.0
 22 JAH = 0.5
 M. de uso: 7h 44' bem adaptada
 trocou o filtro Jua

13/12 P = f_{cmH_2O}
22 IAH = 0,6 elev
Fuga = 3,2 l/min
m. de uso: 7h55'

Sua cláudia

28/02 P = f_{cmH_2O}
23 m. de uso: 8h
Fuga = 4,5 l/min
IAH = 0,5 elev

Bem adaptada, rela
ta melhora da sons
eiva.

fua

16/06/23 P = f_{cmH_2O}
IAH = 0,3 elev
Fuga = 3,1 l/min.

- melhora da sustentação
- 1x noturno

fua

14/09 P = f_{cmH_2O}
23 m. de uso: 7h
IAH = 0,2
Fuga = 2,5 l/min

não está utilizando
as 8h, pois está tiran-
do a maré.

fua

07/12 P = f_{cmH_2O}
23 IAH = 0,1 elev
m. de uso: 6h44'
Bem adaptada.

fua

08/02 P = f_{cmH_2O}
24 IAH = 0,2 elev
m. de uso: 7h50'
Fuga = 6,5 l/min

está bem adaptada

fua

09/05/24 P = f_{cmH_2O}
IAH = 0,2 elev
m. de uso: 7h25m
Fuga: 9,6 l/min

* troco filtro
Bem adaptada

Natecha

11/07 P = f_{cmH_2O}
24 IAH = 0,2 elev
m. de uso: 7h
fuga = 5,3 lpm.

fua

05/09 P = f_{cmH_2O}
21 IAH = 0,1 elev
m. de uso: 8h11'

fua

11/12 P = f_{cmH_2O}
24 IAH = 0,1 elev
m. de uso: 7h38'
Fuga = 11,2 lpm.

adaptou bem.

Sua cláudia

05/03 P = f_{cmH_2O}
2025 IAH = 0,2 elev
m. de uso: 7h40'
Fuga = 10

ED;
m. gel

do.

AR:

TE

S AN

flim

nll fu
patol

AME:

nom

05/03

P= 7 cm H₂O

hoco filtro N30i

2025

IAH= 0,2 x/h

man: 7h40 min

quinto higienizac

Silva

fuga: 18 l/min

05/06

não troquei a mare.
mantendo 7h20'

fua.



NOME DO PACIENTE: Mariana Venancia Sanches

Caro colega, encaminho senhora Mariana Venancia Sanches para avaliação de uso de CPAP devido apneia acentuada.

Grato.

Dr. Carlos Alberto Gonçalves Maximo
CRM 124085 - SP
Cardiologia

Dr. Carlos Alberto Gonçalves Maximo
CRM-SP 124085 - Cardiologista e Ecocardiografista - Título Especialista SBC/DIC

Espaço Saúde - Vale Sul Shopping - São José dos Campos - SP
Tel: (12) 3028-5676 | (12) 99101-2889
www.artere.com.br

Nome: MARIANA VENANCIA SANCHES
Data de Nascimento: 18-5-1948
IMC: 30,80
Sexo: Feminino
Data do exame: 23-10-2020

Peso: 74 kg
Altura: 1,55 m
Medico: DR. CARLOS ALBERTO MAXIMO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-10-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 427,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,0 e 115,0 minutos. O tempo total de sono foi de 342,0, eficiência de 80,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 61,8%; estágio N3: 17,5%; sono REM: 17,0%. O índice de despertares foi de 17,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopnéia total foi de 30,7, sendo elas 21 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 154 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 82%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 61 - 81 bpm e NREM de 60 - 77 bpm.

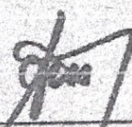
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (03), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 30,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157